Ospedale Pediatrico Il Girasole
SC Radiologia Pediatrica
Direttore: Dott.ssa Elisabetta Ghiglione

Salita San Bartolomeo Alto 6
16136 Genova
Radiologia: 010 5563310
radiologia@ilgirasole.example.it

REFERTO RADIOLOGICO PEDIATRICO

Ecografia renale e vescicale - Cistouretrografia minzionale (CUM)

DATI DEL PAZIENTE

Paziente:	**Ferrando Leonardo**	Data di nascita:	**17/04/2020**
Codice fiscale:	**FRRLRD20D17D969L**	Età:	**5 anni e 10 mesi**
Peso / altezza:	**19,4 kg / 112 cm**	Esercente la resp. genitoriale:	**sig.ra Silvia Parodi (madre)**
Recapito genitore:	**+39 340 918 2276**		

Data esami: 12 febbraio 2026
Richiedente: Dott.ssa Beatrice Canepa

Ricetta NRE: 070A06210993381
Provenienza: Ambulatorio di Nefrologia Pediatrica

Ecografia: PED-US-26-4410

CUM: PED-RX-26-1187

QUESITO CLINICO

Bambino in età prescolare con infezioni febbrili delle vie urinarie ricorrenti (tre episodi nell'ultimo anno, l'ultimo il 28.12.25 con ricovero presso la nostra u.o. di Pediatria d'Urgenza), in profilassi antibiotica con trimetoprim-sulfametossazolo a basso dosaggio. Una precedente ecografia, eseguita il 15/01/2026 presso il Centro Medico Pediatrico Arcobaleno, descriveva una dilatazione pielica sinistra. Si richiede studio del reflusso vescico-ureterale.

ECOGRAFIA RENALE E VESCICALE

Esame eseguito con sonde convex e lineare ad alta frequenza, a vescica piena e dopo minzione. Il piccolo ha collaborato con l'aiuto della madre.

Rene	Diametro longitudinale	Spessore parenchimale	Pelvi (DAP)	Note
Destro	74 mm	13,5 mm	non dilatata	Normale differenziazione cortico-midollare
Sinistro	81 mm	11,5 mm	9,5 mm	Dilatazione pielo-caliceale, uretere prossimale visibile (4 mm)

Vescica a pareti regolari, di spessore 2,6 mm a riempimento. Ureteri distali non dilatati a vescica piena. Residuo post-minzionale di 14 mL.

CISTOURETROGRAFIA MINZIONALE

Previo consenso informato sottoscritto dalla madre, sig.ra Parodi, e applicazione di gel anestetico, cateterismo vescicale con catetere 6 Fr eseguito dall'inf. Marta Oliveri. Riempimento per gravità con iopamidolo diluito al 30% fino a un volume di 180 mL, con acquisizioni in fase di riempimento, minzionale e post-minzionale in scopia pulsata a basso dosaggio.
Si documenta reflusso vescico-ureterale passivo e attivo a sinistra di III grado (classificazione dell'International Reflux Study), con riempimento dell'uretere, della pelvi e dei calici, che appaiono lievemente dilatati, senza smussamento dei fornici. Non reflusso a destra. Uretra di normale calibro e morfologia in fase minzionale. Svuotamento vescicale completo.

Dati dosimetrici CUM

Tempo di scopia	Prodotto dose-area (DAP)	Immagini acquisite	Protezione gonadi
0,8 min	4,6 µGy·m²	9 (last image hold)	Sì

CONCLUSIONI

Reflusso vescico-ureterale sinistro di III grado, passivo e attivo, con lieve dilatazione delle cavità renali omolaterali. Reni di dimensioni nei limiti per età; non reflusso a destra.
Si rimanda al nefrologo pediatra, Dott.ssa Canepa, per la prosecuzione della profilassi e per la programmazione della scintigrafia renale con DMSA.

Esami eseguiti con la collaborazione del medico in formazione specialistica dott. Pietro Bozzo. La madre, sig.ra Silvia Parodi, è stata informata dell'esito al termine dell'esame.

Il Medico Radiologo Pediatra
Dott. Emanuele Rebora

Genova, 13/02/2026

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.